Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
4ª Vara Cível da Comarca de Caxias do Sul

Rua Dr. Montaury, 2107, 4º andar - Bairro: Exposição - CEP: 95080-155 - Fone: (54) 3039-9081 - balcão virtual:(054) 99920.8496 - Email: frcaxsul4vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5043195-89.2022.8.21.0010/RS

AUTOR: TAYLON DOS REIS HOFFMAN

RÉU: UNIMED SERRA GAUCHA/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

SENTENÇA

TAYLON DOS REIS HOFFMAN ajuizou **Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela para Fornecimento de Medicamento** em face de **UNIMED SERRA GAUCHA/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA**. Relatou ser portador de Atrofia Muscular Espinhal (AME) Tipo III (CID10 G12), diagnosticada aos 20 anos através de testagem genética. Nos últimos quatro anos, devido à evolução da doença, o quadro clínico de tetraparesia está levando ao risco de perda permanente da capacidade de deambulação. O médico que o acompanha indicou o tratamento com Nusinersena (Spinraza), na dose de 12mg (5ml), como indispensável para a manutenção de sua vida e para preservar as funções motoras atualmente presentes. O não uso do medicamento pode levar à perda definitiva da marcha de forma independente. A requerida indeferiu a solicitação de cobertura do tratamento, alegando que o medicamento teria caráter experimental para o subtipo da patologia do autor (AME tipo III b). Argumentou que a postura da requerida coloca em risco seu direito fundamental à vida, pois, sem a medicação, a doença se agrava, levando à dependência de terceiros para atividades básicas e a um óbito precoce. Sustentou que os planos de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor e que o medicamento Nusinersena (Spinraza) é aprovado pela ANVISA. Requereu, liminarmente, o deferimento da antecipação de tutela para determinar o fornecimento do medicamento Nusinersena, com a imposição de multa diária em caso de descumprimento e, no mérito, a procedência da ação com a confirmação da medida liminar. Postulou a gratuidade da justiça. Juntou procuração e documentos. Deu à causa o valor de R$12.145,00.

Deferida a gratuidade da justiça e indeferida a liminar.

Foi interposto agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento.

Citada, a parte requerida apresentou contestação, na qual alegou, em suma: a) o tratamento com nusinersena (Spinraza) 12mg/5ml foi indeferido por não haver evidências científicas de eficácia para o subtipo da patologia do autor; b) o contrato de plano de saúde do autor é coletivo empresarial, firmado em 21/01/2013, e se submete integralmente à Lei nº 9.656/98 e às normas da ANS, que excluem a cobertura para tratamentos experimentais; c) para a idade do demandante não existe qualquer comprovação científica de que o medicamento indicado poderá ter qualquer benefício. Requereu a improcedência dos pedidos. Juntou procuração e documentos.

Em réplica, a parte autora repisou os argumentos da inicial e rebateu os da contestação.

Deferido o pedido da ré (evento 25) para juntada do laudo pericial como prova emprestada (evento 33).

Deferida a produção de prova pericial, cujo laudo veio aos autos no evento 71, DOC1.

Formulado novo pedido de tutela antecipada, que restou indeferido.

Declarada encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório. DECIDO.

Entendo que prospera a pretensão da parte autora.

Incontroverso que a parte autora é beneficiária do plano de saúde fornecido pela demandada, bem como que teve negado seu pedido administrativo para fornecimento do medicamento.

A necessidade de utilização do medicamento pela parte autora se mostrou incontroversa diante do laudo médico acostado, o qual detalha os tratamentos já realizados, sem êxito, a gravidade da condição da parte autora, bem como que se trata do único tratamento disponível para o demandante (evento 1, DOC6):

Laudo médico referente ao paciente Taylon dos Reis Hoffman acompanhado por mim desde 03/05/2022 com diagnóstico de ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL (AME) TIPO III. CID10: G12
O paciente percebeu início dos sintomas de fraqueza e má performance física aos 14 anos de idade. A confirmação definitiva através da testagem genética se deu em 14/08/2019 (zero cópias do SMN1 e 4 cópias de SMN2) quando o paciente tinha 20 anos de idade. Nos últimos quatro anos, devido a progressão da doença, o quadro clínico de uma tetraparesia está levando ao risco de perda permanente da capacidade de caminhar.
Suas escalas funcionais atuais são as seguintes: Testes cronometrados: TC6M= 328 mts, TC10M = 8,97 mts, Subir 4 degraus: 6,44 s Descer 4 degraus: 2,51 s HFMSE: 41/66 RULM: 35/37 MFM: Escore total = 77%D1= 46% (em pé e transferências)D2= 97% (função motora axial e proximal)D3= 100% (função motora distal).

Tem indicação de usar o medicamento nusinersena com o objetivo de preservar as funções motoras atualmente presentes, fundamentais para qualidade de vida e preservação da marcha sem uso de órteses.
O NÃO USO DO MEDICAMENTO PODE LEVAR A PERDA DEFINITIVA DA MARCHA DE FORMA INDEPENDENTE.

Mais importante ainda foi a perícia realizada junto ao DMJ, que esclareceu inúmeros pontos ao juízo, que destaco a seguir (evento 71, DOC1).

> "O tratamento tem sido principalmente de suporte e, mais recentemente, foi disponibilizada terapia modificadora da doença com Nusinersena, Risdiplam e Onsemnogene Abeparvovec.
>
> Para bebês e crianças muito pequenas com AME que não são dependentes de ventilador, recomenda-se o tratamento com terapia modificadora da doença usando Nusinernenam Onasemnogene Abeparvovec ou Risdiplam, quando disponível (Grau 1B). Para crianças mais velhas (idade ≥2 anos) e adultos com sintomas moderados de AME, sugerimos tratamento com Nusinersena ou Risdiplam (Grau 2C). A eficácia de Onasemnogene Abeparvovec em crianças com idade ≥2 anos é desconhecida.
>
> Todos estes medicamentos são disponíveis no Brasil pelo SUS, em protocolo específico de tratamento da doença para a AME tipo 1. O SUS oferece Nusinersena para os tipos 2 e 3 na modalidade de compartilhamento de risco com o fabricante (risk-sharing). Neste formato, o governo paga pelo medicamento somente se houver melhora da saúde do paciente."
>
> ...
>
> "**No caso em tela, considerando a piora da fraqueza nos últimos meses com possibilidade de perda da deambulação independente, há recomendação técnica para uso de Nusinersena.** (grifei)
>
> Este medicamento tem cobertura obrigatória estabelecida no âmbito da Saúde Suplementar, em conformidade com a alínea "d", inciso II, do art. 12 da, o Lei nº 9.656/1998. O medicamento Nusinersena é de cobertura obrigatória quando prescrito pelo médico assistente, para administração durante internação hospitalar, para indicação de uso prevista em bula, o tratamento da Atrofia Muscular Espinhal (AME) 5q."

Ainda, em resposta ao quesito letra "K" da requerida, se manifestou a perita:

k) Qual o tratamento preconizado para o caso clínico do autor?

k) Terapia modificadora da doença com Nusinersena e tratamento de reabilitação.

Assim, entendo que restou demonstrado que o medicamento pleiteado é indicado e essencial ao tratamento do autor. Há evidências científicas de sua indicação para o subtipo clínico de AME que foi diagnosticado na parte autora e a falta de uso dele pode ocasionar a perda definitiva da deambulação independente.

Também sobre o fornecimento do medicamento, tem-se o posicionamento do TJRS:

> *APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO SPINRAZA (NUSINERSENA) PARA TRATAMENTO DE ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL (AME) TIPO III. MEDICAMENTO INJETÁVEL DE USO NÃO DOMICILIAR. LAUDO MÉDICO QUE APONTA A NECESSIDADE DO TRATAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA À PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 51001625020238210001, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em: 25-09-2024)*

Isso posto, **JULGO PROCEDENTE** a ação proposta por TAYLON DOS REIS HOFFMAN contra UNIMED SERRA GAUCHA/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA, para **CONDENAR** o réu ao para determinar à demandada que forneça ao autor o medicamento: "USO INTRATECAL HOSPITALAR: NUSINERSENA 12 mg/5 mL (5 mL)---CONTINUO Dose de carga (tratamento de indução): 12 mg(5 mL) uma vez a cada 14 dias por 3 doses; em seguida, 12 mg uma vez 30 dias após a terceira dose; Dose de manutenção: 12 mg(5 mL) uma vez a cada 4 meses, forma prescrita pelo médico assistente no laudo do evento 1, DOC7, tudo nos termos da fundamentação acima, sendo que, diante do resultado da demanda, defiro o pedido de antecipação de tutela, para determinar à parte demandada o fornecimento da referida medicação, no prazo de 30 dias, a contar da intimação da sentença.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios do patrono da parte adversa, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (índice do IPCA), nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Em sendo interposto recurso, dê-se vista à parte contrária para contrarrazões e, se embargos de declaração, voltem conclusos; se apelação, não havendo recurso adesivo, subam os autos ao E. TJRS.

Intimações agendadas no sistema.

Transitado em julgado, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA BAMPI, Juíza de Direito**, em 10/06/2025, às 16:36:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10084089179v20** e o código CRC **e12d48f0**.